

**ЗВІТ ЩОДО ПЕРЕВІРОК ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ТА
ДІЯЛЬНОСТІ ПОЗАШТАТНИХ ВІЙСЬКОВО-ЛІКАРСЬКИХ КОМІСІЙ ПРИ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ
ПІДТРИМКИ ВІННИЦЬКОЇ, ВОЛИНСЬКОЇ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ,
ЗАКАРПАТСЬКОЇ, ЗАПОРІЗЬКОЇ, ЖИТОМИРСЬКОЇ, КИЇВСЬКОЇ,
КИРОВОГРАДСЬКОЇ, ЛЬВІВСЬКОЇ, МИКОЛАЇВСЬКОЇ, ПОЛТАВСЬКОЇ,
РІВНЕНСЬКОЇ, СУМСЬКОЇ, ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ, ХАРКІВСЬКОЇ,
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ, ЧЕРКАСЬКОЇ, ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ, ЧЕРНІГІВСЬКОЇ
ОБЛАСТЕЙ ТА М. КИЇВ, ЯКІ ПРОВОДИЛИСЬ ПРОТЯГОМ
ЧЕРВНЯ - ЛИПНЯ 2025 РОКУ**

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Наказом Міністерства охорони здоров'я України (далі – МОЗ) від 10 травня 2025 року № 794 «Про утворення та затвердження персональних складів робочих груп з питань повторної перевірки організації медичних оглядів та діяльності позаштатних військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки» (далі - ВЛК) утворено та затверджено персональні склади робочих груп з питань повторної перевірки організації медичних оглядів та діяльності позаштатних військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки вказаних областей, наказом МОЗ від 17 травня 2025 року № 835 внесені зміни щодо термінів проведення перевірок ВЛК та до складу робочих груп.

До складу робочих груп увійшли представники Міністерства охорони здоров'я України, Національної служби здоров'я України, Командування Медичних сил Збройних Сил України, центральної військово-лікарської комісії та закладів охорони здоров'я.

Звіт сформований на підставі окремих звітів голів робочих груп з питань повторної перевірки організації медичних оглядів та діяльності позаштатних військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки перевірки військово-лікарських комісій вказаних областей.

Зі сторони Міністерства охорони здоров'я України надано чек-лист для заповнення результатів перевірок, в якому містилися пункти щодо організації роботи позаштатних військово-лікарських комісій, дотримання вимог за пакетом Програми медичних гарантій та наказу Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800 (зі змінами).

Було перевірено всього 406 з 445 (91,2%) ВЛК у вказаних областях, а саме:

1. Вінницька область – 30 з 30.
2. Волинська область – 18 з 18 ВЛК.
3. Дніпропетровська область – 20 з 38 ВЛК.
4. Закарпатська область – 14 з 14.
5. Запорізька область – 9 з 9 ВЛК.
6. Житомирська область – 21 з 21.
7. Київська область – 28 з 29 ВЛК.

8. Кіровоградська область – 22 з 23 ВЛК.
9. Львівська область – 26 з 27 ВЛК.
10. Миколаївська область – 22 з 23 ВЛК.
11. Полтавська область – 29 з 29 ВЛК.
12. Рівненська область – 19 з 19 ВЛК.
13. Сумська область – 17 з 17 ВЛК.
14. Тернопільська область – 18 з 18 ВЛК.
15. Харківська область – 30 з 31 ВЛК.
16. Хмельницька область – 21 з 21 ВЛК.
17. Черкаська область – 9 з 24 ВЛК.
18. Чернівецька область – 13 з 14 ВЛК.
19. Чернігівська область – 27 з 27 ВЛК.
20. м. Київ – 13 з 13 ВЛК.

Зазначимо загальні результати проходження ВЛК в розрізі кожної області.

2025 РІК						
Регіон	К-сть розпочатих епізодів за 2025 рік	Середня тривалість епізодів, розпочатих у 2025 році	К-сть закритих епізодів розпочатих у 2025 році	% закритих епізодів за 2025 рік	З них закритих епізодів відповідно до визначених термінів	% закритих епізодів відповідно до визначених термінів
ВІННИЦЬКА	38 637	2,9	36 821	95,3%	36 460	94,4%
ВОЛИНЬСЬКА	33 123	2,0	32 724	98,8%	32 688	98,7%
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	81 498	2,2	80 534	98,8%	80 336	98,6%
ДОНЕЦЬКА	9 308	5,6	8 986	96,5%	8 688	93,3%
ЖИТОМИРСЬКА	38 344	3,5	37 463	97,7%	36 427	95,0%
ЗАКАРПАТСЬКА	24 622	3,1	23 891	97,0%	23 603	95,9%
ЗАПОРІЗЬКА	25 980	2,0	25 418	97,8%	25 359	97,6%
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА	25 270	3,6	24 298	96,2%	23 730	93,9%
КИЇВСЬКА	65 032	3,3	64 215	98,7%	61 005	93,8%
КІРОВОГРАДСЬКА	23 092	3,9	22 423	97,1%	21 931	95,0%
ЛЬВІВСЬКА	62 369	3,4	60 386	96,8%	59 116	94,8%
ЛУГАНСЬКА	54	65,6	51	94,4%	47	87,0%
МИКОЛАЇВСЬКА	24 266	4,6	23 467	96,7%	22 596	93,1%
М. КИЇВ	82 638	2,3	77 448	93,7%	75 965	91,9%
ОДЕСЬКА	39 333	5,1	37 563	95,5%	35 795	91,0%
ПОЛТАВСЬКА	54 032	1,6	53 106	98,3%	53 041	98,2%
РІВНЕНСЬКА	26 002	3,5	24 683	94,9%	24 465	94,1%
СУМСЬКА	26 016	2,5	25 207	96,9%	24 918	95,8%
ТЕРНОПІЛЬСЬКА	24 367	2,4	23 594	96,8%	23 164	95,1%
ХАРКІВСЬКА	66 117	5,1	63 272	95,7%	61 384	92,8%
ХЕРСОНСЬКА	7 116	1,5	6 951	97,7%	6 939	97,5%
ХМЕЛЬНИЦЬКА	40 000	3,3	38 581	96,5%	38 072	95,2%
ЧЕРКАСЬКА	36 420	4,4	34 345	94,3%	33 682	92,5%
ЧЕРНІВЕЦЬКА	17 402	2,6	16 958	97,4%	16 785	96,5%
ЧЕРНІГІВСЬКА	28 844	4,0	27 181	94,2%	26 544	92,0%
ЗАГАЛОМ	899 882		869 566	96,6%	852 740	94,8%

ДООБСТЕЖЕННЯ В РАМКАХ ВЛК (2025 РІК).

Найбільше пацієнтів скеровуються і мають незакриті дообстеження:

- інші дослідження
- консультація травматолога
- консультація інфекціоніста

У середньому по Україні 27% пацієнтів скеровуються на дообстеження.

Однак є області, де цей відсоток значно вищий:

- Чернівецька – 54%
- Івано-Франківська область – 50%

- Полтавська – 42%

Найнижчий відсоток завершених ВЛК пацієнтами, які були скеровані на дообстеження:

- Херсонська – 13%
- Київ – 18%
- Волинська – 19%
- Чернігівська – 19%
- Львівська – 20%

В Миколаївській, Черкаській, Харківській областях найбільший середній термін проходження ВЛК (понад 4 дні)

Заклади з великою кількістю направлень на дообстеження і гіршим % їх закриття:

- Черкаська обласна лікарня;
- КДЦ Голосіївського району Києва;
- Пустомитівська лікарня Львівська область;
- Дергачівська ЦЛ Харківська область;
- Обласна клінічна лікарня ім. Гербачевського Житомирська область;
- Вінковецька багатопрофільна лікарня Хмельницька область;
- Вознесенська багатопрофільна лікарня Миколаївська область;
- Коростенська ЦМЛ Житомирська область;
- КДЦ Солом'янського району Києва.

Найбільше направлень на дообстеження мають такі заклади:

- **КДЦ Солом'янського району Києва** – 2585 пацієнтів скеровано на «консультацію інфекціоніста» (11,7% від усіх направлень по країні, при цьому 16,5% не завершили дообстеження);
- **Вишнівська міська лікарня Київська область** – 4320 пацієнтів скеровано на «інші дослідження» (4,3% від усіх направлень по країні);
- **Міська поліклініка № 2 Чернівці** – 3745 пацієнтів скеровано на «консультацію травматолога» (5% від усіх направлень по країні);
- **Запорізька ОКЛ** – 3646 пацієнтів скеровано на «інші дослідження» (3,7% від усіх направлень по країні);
- **ОКЛ ім. Гербачевського Житомирська область** – 2766 пацієнтів скеровано на «інші дослідження» (2,8% від усіх направлень по країні, при цьому 10% не завершили дообстеження).

ПОРУШЕННЯ

Вінницька область:

Проведено перевірку 30 ВЛК при ТЦК та СП. Виявлено основні порушення станом на момент перевірки:

1. Кількість не завершених епізодів в ЕСОЗ – 1194 (3,8%), не завершили медичні огляди більше 14 днів 1976 (6,3%).

- Більше незавершених епізодів ВЛК на базі таких закладів:
- КНП «Теплицька міська лікарня» Теплицької селищної ради;
 - КНП «Ямпільська територіальна лікарня» Ямпільської міської ради;
 - КНП «Тульчинська районна лікарня» Тульчинської міської ради.
2. Виявлені ВЛК, в яких маршрутизація військовозобов'язаних на дообстеження в інші заклади охорони здоров'я відсутня; відсутнє положення про ВЛК, відсутні посадові інструкції членів ВЛК, в таких закладах:
- КНП «Немирівська міська лікарня» Немирівської міської ради;
 - КНП «Оратівська лікарня планового лікування» Оратівської селищної ради.
3. Не проводиться супровід військовозобов'язаних працівниками ТЦК та СП, ВЛК на базі :
- КНП «Тростянецька центральна районна лікарня» Тростянецької міської ради;
 - КНП «Мурованокуриловецька центральна районна лікарня» Мурованокуриловецької селищної ради.
4. Направлення військовозобов'язаних на дообстеження не обґрунтовані, ВЛК на базі закладів:
- КНП «Липовецька міська лікарня» Липовецької міської ради;
 - КНП «Оратівська лікарня планового лікування» Оратівської селищної ради;
 - КНП «Літинська центральна районна лікарня» Літинської селищної ради;
 - КНП «Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування» Бершадської міської ради;
 - КНП «Барська міська лікарня» Барської міської ради;
 - КНП «Калинівська центральна районна лікарня» Калинівської міської ради;
 - КНП «Козятинська центральна районна лікарня» Козятинської міської ради;
 - КНП «Хмільницька центральна районна лікарня» Хмільницької міської ради.
5. Встановлюються діагнози, які не підтверджені лабораторно – інструментальними дослідженнями, ВЛК на базі таких закладів:
- КНП «Чечельницька районна лікарня» Чечельницької селищної ради;
 - КНП «Жмеринська центральна районна лікарня» Жмеринської міської ради;
6. Не проводиться оцінка вакцинального статусу військовозобов'язаних, ВЛК на базі:
- КНП «Немирівська міська лікарня» Немирівської міської ради.

Волинська область:

Було перевірено 18 з 18 існуючих ВЛК на базі закладів охорони здоров'я.

Виявлено наступні недоліки:

1. Всього по області станом на момент перевірки кількість незавершених епізодів 633 (2,2%), не завершили медичний огляд більше 14 днів – 26 (0,9%), направлено на дообстеження - 1996 (6,9%), не проводиться оцінка вакцинального статусу військовозобов'язаних; не ведеться контроль за обґрунтованістю направлень на дообстеження; встановлені факти некоректного застосування переліку хвороб згідно наказу МОУ № 402 від 14.08.2008. Такі порушення більше характерні в таких ВЛК на базі закладів охорони здоров'я:

- КНП «Камінь-Каширська центральна районна лікарня» Камінь-Каширської міської ради;
- КНП «Любомльське ТМО» Любомльської міської ради;
- КНП «Горохівська багатопрофільна лікарня».

Дніпропетровська область:

Було перевірено 20 з 32 ВЛК на базі закладів охорони здоров'я. Виявлені наступні порушення:

1. Резервний склад окремих ВЛК при ТЦК та СП не укомплектований в ВЛК на базі комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Межівської селищної ради», що подовжує терміни проведення медичних оглядів військовозобов'язаних у разі відпустки чи хвороби основного члена ВЛК, для якого відсутній резервний склад.

2. ВЛК вимушені направляти військовозобов'язаних на проходження КТ та/або МРТ до інших закладів, ВЛК на базі таких закладів:

- КНП «Жовтоводська міська лікарня» Жовтоводської міської ради;
- КП „Криворізька міська лікарня № 7” Криворізької міської ради;
- КП “Софіївська центральна лікарня” Софіївської селищної ради;
- КНП “Павлоградська міська лікарня №1” Павлоградської міської ради”.

3. Також, наявні не закриті епізоди медичних оглядів за січень – травень 2025 року, більшість з яких пов'язана з неповерненням військовослужбовців після дообстеження. Всього по області випадків незавершених епізодів – 304 (0,44%), не завершили медичний огляд більше 14 днів – 304 (0,44%). Найбільша кількість незакритих епізодів по ВЛК таких закладів:

- КНП “Покровська лікарня” Покровської селищної ради Дніпропетровської області” та КНП “Центральна лікарня” Межівської селищної ради”.
- КП “Верхньодніпровська центральна міська лікарня” Верхньодніпровської міської ради”;
- КНП “Криворізька міська лікарня № 5” Криворізької міської ради;
- КП “Криворізька центральна районна лікарня”;
- КП “Апостолівська міська лікарня” Апостолівської міської ради;
- КП “Нікопольська міська лікарня № 4” Нікопольської міської ради”;
- КНП “Шахтарська міська лікарня” Шахтарської міської ради”.

Закарпатська область:

Було перевірено 15 з 15 ВЛК на базі закладів охорони здоров'я. Виявлені наступні порушення:

1. По області направлених військовозобов'язаних на додаткові обстеження 4129 (23,4%), завершили ВЛК з направленням на ДМО – 4009 (97,0%), не завершили медичний огляд більше 14 днів – 269 (6,5%), з них не завершили медичний огляд взагалі - 11 (4,08%). Не ведеться контроль за дотриманням термінів проходження медичних оглядів, зокрема при дообстеженні, та інформація для організації розшуку не передається до ТЦК.

Більше характерно дані порушення для ВЛК при таких заклад охорони здоров'я:

- КНП «Тячівська районна лікарня» Тячівської міської ради Закарпатської області;

- КНП «Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О. П.» Хустської міської ради Закарпатської області;

- КНП «Свалявська міська лікарня» Свалявської міської ради Закарпатської області;

- КНП «Великобerezнянська лікарня» Великобerezнянської селищної ради Ужгородського району;

- ВЛК на базі КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради;

- ВЛК на базі КНП «Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О. П.» Хустської міської ради;

- ВЛК на базі КНП «Свалявська міська лікарня» Свалявської міської ради Закарпатської області.

2. Не укомплектований штат ВЛК, більше характерно для ВЛК на базі КНП «Великобerezнянська лікарня» Великобerezнянської селищної ради Ужгородського району (відсутній хірург).

3. При скеруванні на додаткові медичні обстеження не дотримуються вимоги чинного наказу Міністерства оборони України від 14.08.2008 № 402 (зі змінами), більше характерно для ВЛК на базі:

- КНП «Великобerezнянська лікарня» Великобerezнянської селищної ради Ужгородського району;

- ВЛК на базі КНП «Тячівська районна лікарня» Тячівської міської ради Закарпатської області.

4. Не відповідає вимогам матеріально – технічна база, більше характерно для ВЛК на базі КНП «Великобerezнянська лікарня» Великобerezнянської селищної ради Ужгородського району.

5. Виявлені факти не обґрунтованих діагнозів, більше характерно для ВЛК на базі:

- ВЛК на базі КНП «Тячівська районна лікарня» Тячівської міської ради;

- КНП «Воловецька центральна лікарня Воловецької селищної ради» Закарпатської області.

6. Відсутня усвідомлена згода особи на проведення психіатричного огляду, характерно для всіх ВЛК.

7. Дані медичних оглядів не вводиться в ЕСОЗ в ВЛК на базі КНП «Воловецька центральна лікарня Воловецької селищної ради» Закарпатської області:

Запорізька область:

Було перевірено 9 з 9 ВЛК. Виявлені наступні порушення:

1. Лише у КНП «Запорізька обласна клінічна лікарня» ЗОР, на базі якої створено обласний мобілізаційний центр, всі лабораторні та інструментальні дослідження, у тому числі КТ та МРТ, проводяться в одному закладі, де функціонує ВЛК.

Інші ВЛК вимушені направляти на проходження КТ та/або МРТ до інших закладів охорони здоров'я, характерно для ВЛК на базі таких закладів:

- КНП «Міська лікарня №9» Запорізької міської ради;
- КНП «Міська лікарня №8» Запорізької міської ради;
- КНП «Міська лікарня №7» Запорізької міської ради;
- КНП «Міська лікарня №4» Запорізької міської ради;
- КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої допомоги» Запорізької міської ради»;
- КНП «Вільнянська багатoproфільна лікарня» Вільнянської міської ради;
- КНП «Клініка «Сімейний лікар» Широківського району Запорізького області;
- КНП «Новомиколаївська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Новомиколаївської селищної ради

2. Не області не контролюється дотримання термінів проходження медичних оглядів, їх завершення. По області не завершили медичний огляд взагалі – 892(3,57%), не завершили медичний огляд більше 14 днів – 821 (3,28%).

Наявні випадки не закритих епізодів, військовозобов'язані взагалі не повертаються після направлення на дообстеження, характерно ВЛК на базі закладів:

- КНП «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької міської ради, 76 незакритих епізоди станом на момент перевірки ;
- КНП «Міська лікарня №9» Запорізької міської ради, 106 незакритих епізодів;
- КНП «Міська лікарня №8» Запорізької міської ради, 70 незакритих епізодів;
- КНП «Міська лікарня №7» Запорізької міської ради, 203 незакритих епізодів;
- КНП «Міська лікарня №4» Запорізької міської ради, 138 незакритих епізодів;
- КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої допомоги» Запорізької міської ради», 71 незакритих епізодів;
- КНП «Вільнянська багатoproфільна лікарня» Вільнянської міської ради, найбільша кількість незакритих епізодів -202 (15%);
- КНП «Клініка «Сімейний лікар» Широківського району Запорізького області – 57 незакритих епізодів.
- КНП «Новомиколаївська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Новомиколаївської селищної ради, 19 незавершених епізодів.

Житомирська область:

Було перевірено 22 з 22 ВЛК. Виявлені наступні порушення:

1. Не забезпечений супровід військовозобов'язаних представниками ТЦК та СП в усіх ВЛК;
2. Не забезпечені умови для роботи ВЛК, окремі кабінети не відповідають розмірам, в одних кабінетах проводиться огляд фахівцями без розмежування ширмами в ВЛК на базі КНП «Баранівська лікарня» Баранівської міської ради.
- 3 Відсутній контроль за дотриманням термінів проходження дообстеження. По області станом на момент перевірки не завершили медичний огляд 1776 (6,0%), не завершили медичний огляд більше 14 днів 143 (0,5%). Більше характерно для ВЛК на базі таких закладів:
 - КНП «Чуднівська лікарня» Чуднівської міської ради;

- КНП « Житомирська багатoproфiльна лiкарня» Новогуївинської селищної ради.
 - КНП «Обласна клінічна лікарня ім. Гербачевського», не ведеться контроль за направленнями на дообстеження – 2766 пацієнтів скеровано на «інші дослідження» (2,8% від усіх направлень по країні, при цьому 10% не завершили дообстеження).
4. Накази про створення ВЛК потребують оновленню, маршрути пацієнтів потребують коректуванню, в існуючій маршрутах не зазначена можливість направлення військовозобов'язаних на дообстеження в інші заклади охорони здоров'я, для таких ВЛК на базі;
- КНП «Бердичівська міська лікарня» Бердичівської міської ради;
 - КНП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка» Житомирської міської ради;
 - КНП «Романівська лікарня» Романівської селищної ради;
 - КНП «Чуднівська лікарня» Чуднівської міської ради;
 - КНП «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради;
 - КНП «Андрушівська лікарня» Андрушівської міської ради;
 - КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради;
 - КНП «Народицька лікарня» Народицької селищної ради;
 - КНП «Радомишльська лікарня» Радомишльської міської ради.
5. Відсутні добровільні згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та добровільні згоди на психіатричний огляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу» в усіх ВЛК.
7. Не проводиться контроль вакцинального статусу військовозобов'язаних в усіх ВЛК.
8. Неукомплектовані штатами ВЛК на базі КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської селищної ради, неукомплектованість штату, зокрема відсутній невропатолог, ВЛК з 01.05.2025 року взагалі припинила свої роботи;

Київська область.

Було перевірено 28 з 28 ВЛК області. Виявлені наступні порушення:

1. ВЛК на базі КНП «Бориспільська багатoproфiльна лiкарня iнтенсивного лiкування - військовозобов'язані проходять медичний огляд ВЛК не в одному приміщенні; лікарі терапевт, хірург, психіатр та ЛОР здійснюють огляд в поліклініці, не за місцем проведення ВЛК, що призводить до зниження контролю проходження військовозобов'язаними мобілізаційного ресурсу, ВЛК на базі:
2. Не укомплектований штат ВЛК на базі таких закладів:
 - КНП «Березанська міська лікарня» Березанської міської ради», а саме - резервний склад ВЛК відсутній у зв'язку з нестачею лікарів-спеціалістів, а саме: отоларинголог, офтальмолог, психіатр;
 - КНП «Баришівська багатoproфiльна лiкарня» Баришівської селищної ради;
 - КНП «Макарівська багатoproфiльна лiкарня iнтенсивного лiкування» Макарівської селищної ради, в основному складі лише одна медична сестра; резервний склад – відсутні: офтальмолог, отоларинголог, медичні сестри;

3. ВЛК на базі - КНП Кагарлицької міської ради «Кагарлицька багатoproфільна лікарня» не проводиться супровід військовозобов'язаних працівниками ТЦК та СП,

4. Не ведеться контроль за оформленням відповідної медичної документації, ВЛК на базі:

- КНП БМР «Богуславська центральна лікарня» Богуславської міської ради;
- КНП Миронівської міської ради «Миронівська опорна багатoproфільна лікарня»;
- КНП «Рокитнянська багатoproфільна лікарня» Білоцерківського району;
- КНП «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради»

2. Виявлені факти некоректного застосування нормативно – правових актів при проведенні ВЛК, потрібно провести навчання працівників ВЛК на базі таких закладів охорони здоров'я:

- КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради;
- КНП Володарської селищної ради «Володарська лікарня»;
- КНП «Переяславська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування»;
- КНП «Тетіївська центральна лікарня» Тетіївської міської ради;
- КНП Фастівської міської ради «Фастівська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Фастівської міської ради;
- КНП Яготинської міської ради «Яготинська центральна міська лікарня» ;
- КНП «Броварська багатoproфільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району;
- КНП «Васильківська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Васильківської міської ради;
- КНП «Вишгородська центральна районна лікарня» Вишгородської міської ради;
- КНП Іванківської селищної ради «Іванківська центральна районна лікарня»;
- КНП Обухівської міської ради «Обухівська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування»;
- КНП Таращанської міської ради «Таращанська МЛ»;
- КНП Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня 1»;
- КНП Бородянської селищної ради «Бородянська центральна районна лікарня»
- КНП «Ставищенська лікарня» Ставищенської селищної ради Білоцерківського району;

3. КНП «Вишнівська міська лікарня» Вишневої міської Бучанського району – 4320 пацієнтів скеровано на «інші дослідження» (4,3% від усіх направлень по країні).

Кіровоградська область:

Було перевірено 22 ВЛК з 22 ВЛК на базі закладів охорони здоров'я

Виявлені наступні порушення:

1. Не обґрунтовано направляються військовозобов'язані на дообстеження; так при встановленні необхідності обстежень по гіпертонічній хворобі не зазначаються діагнози ураження органів – мішеней, не визначаються індекс маси міокарда лівого

шлуночка, що є принциповим для визначення ступеню гіпертонічної хвороби, ВЛК на базі таких закладів:

- КНП «Новоархангельська багатoproфільна лікарня» Новоархангельської селищної ради»;

- КНП «Новомиргородська міська лікарня» Новомиргородської міської ради.

2. Не відповідає вимогам матеріально –технічне оснащення, ВЛК на базі:

- КНП «Світловодська центральна районна лікарня» Світловодської міської ради;

3. Є факти допуску до роботи в ВЛК осіб, які не зазначені в наказі про склад ВЛК на базі таких закладів:

- в КНП «Голованівська лікарня Голованівської селищної ради» ВЛК працює без юридично оформленої особи секретаря (визначена в наказі особа була мобілізована до ЗСУ) обов'язки секретаря виконує медична сестра поліклінічного відділення лікарні; голова ВЛК виконує обов'язки члену ВЛК.

- КНП «Благовіщенська лікарня» Благовіщенської міської ради, дані у електронну систему вносить інженер програміст, який не є членом ВЛК;

- КНП «Петрівська центральна лікарня» Петрівської селищної ради: у зв'язку із зміною фахівців голова комісії не затверджено наказом;

- КНП «Вільшанська лікарня» Вільшанської селищної ради, голова ВЛК – психіатр комісії.

4. КНП «Олександрівська лікарня» Олександрівської селищної ради – ЛКК видано 100 необґрунтованих довідок (80 % хворих, є пацієнтами інтернатних закладів психоневрологічного напрямку) про потребу в сторонньому догляді.

5. Не дотримується маршрути пацієнтів, графіки роботи ВЛК на базі таких закладів:

- КНП «Маловисківська лікарня» Маловисківської міської ради;

- КНП «Вільшанська лікарня» Вільшанської селищної ради;

- КНП «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради.

6. Не ведеться контроль за термінами проходження ВЛК на базі:

- КНП «Благовіщенська лікарня» Благовіщенської міської ради.

7. Не ведеться контроль за дотриманням термінів проходження медичних оглядів. Так, станом на момент перевірки 791 (4,5%) не завершили медичні огляди. Гірше ситуація по ВЛК таких закладів:

- КНП «Благовіщенська лікарня» Благовіщенської міської ради;

- КНП «Маловисківська лікарня» Маловисківської міської ради;

- КНП «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради

Львівська область:

Було перевірено 26 ВЛК на базі закладів охорони здоров'я. Виявлені порушення:

1. Не проводиться достатній контроль за дотримання термінів проходження військово-лікарської експертизи. Так по області станом на момент перевірки, не завершили медичний огляд взагалі -2622 (4,46%), не завершили медичний огляд більше 14 днів 2185 (3,72%). Більше характерно для ВЛК на базі таких закладів:

- КНП «Радехівська центральна районна лікарня» Радехівської міської ради;

- КНП «6-а поліклініка м. Львова»;

- КНП «Дрогобицька міська лікарня» Дрогобицької міської ради;

- КНП Пустомитівської міської ради «Пустомитівська лікарня»;

- КНП «Городоцька лікарня» Городоцької міської ради;
 - КНП Яворівської міської ради «Яворівська лікарня»;
 - КНП «Львівська обласна клінічна лікарня».
2. Не проводиться оцінка вакцинального статусу військовозобов'язаних в усіх ВЛК;
3. Не дотримується маршрути, ВЛК на базі таких закладів:
- КНП «Кам'янка –Бузька центральна районна лікарня»;
 - КНП «Радехівська центральна районна лікарня» Радехівської міської ради;
 - КНП Пустомитівської міської ради «Пустомитівська лікарня».
4. Не проводиться контроль за направленнями військовозобов'язаних на дообстеження. Так, станом на момент перевірки в цілому по області направлено на дообстеження 11228 (19,14%). Більше направлень на дообстеження ВЛК на базі таких закладів:
- КНП «Радехівська центральна районна лікарня» Радехівської міської ради;
 - КНП Пустомитівської міської ради «Пустомитівська лікарня»;
 - КНП «Городоцька лікарня» Городоцької міської ради;
 - КНП Яворівської міської ради «Яворівська лікарня»;
 - КНП «Бродівська центральна міська лікарня» Бродівської міської ради.
5. Встановлені випадки зниження ступеню придатності по відношенню до встановленого діагнозу, ВЛК на базі таких закладів:
- КНП Пустомитівської міської ради «Пустомитівська лікарня»;
 - КНП «Жовківська лікарня» Жовківської міської ради.
6. Виявлені випадки технічних проблем у функціонуванні ЕСОЗ, е-ВЛК в ВЛК таких закладів:
- КНП Яворівської міської ради «Яворівська лікарня»;
 - КНП Пустомитівської міської ради «Пустомитівська лікарня»;
 - КНП «Дрогобицька міська лікарня» Дрогобицької міської ради.

Миколаївська область:

Було перевірено 22 ВЛК на базі закладів охорони здоров'я:

1. Не вводиться інформація до реєстру ЕСОЗ в ВЛК на базі таких закладів:
 - КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня» Новоодеської міської ради, закладом не укладено договори з НСЗУ за пакетом медичних послуг № 60, хоча військово-лікарська експертиза проводиться;
 - КНП «Снігурівська міська лікарня» Снігурівської міської ради, вводиться в ЕСОЗ лише 50% даних;
 - КНП Миколаївської міської ради «Міська лікарня №4», закладом не укладено договори з НСЗУ за пакетом медичних послуг № 60; хоча військово-лікарська експертиза проводиться;
 - КНП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради, закладом не укладено договори з НСЗУ за пакетом медичних послуг № 60, хоча військово-лікарська експертиза проводиться.
2. Наявні випадки відсутності чіткого обґрунтування причин скерування на дообстеження чи консультації, що не зафіксовані в формах первинної облікової документації № 025/о, або їх відсутність, поодинокі випадки відсутності згоди на

обробку персональних даних, у тому числі при скеруванні на психіатричні огляди, більше характерно для ВЛК на базі таких закладів:

- КНП «Березанська ЦРЛ» Березанської селищної ради;
- КНП «Первомайська Центральна районна лікарня» Первомайської міської ради.

3. В усіх ВЛК на базі закладів охорони здоров'я не запроваджено офіційне листування з ТЦК та СП щодо випадків порушення термінів оглядів пацієнтами, комунікація з визначеного питання здійснюється в телефонному режимі, характерно для всіх ВЛК

Полтавська область:

Було проведено перевірку 29 ВЛК на базі закладів охорони здоров'я.

1. Має місце проведення військово-лікарської експертизи поза межами закладів охорони здоров'я, стосується для ВЛК таких закладів:

- КП «3-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради»;
- КП «1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради»
- КП «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради;
- КП «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» Миргородської міської ради.

2. Виявлені не обгрунтовані випадки направлення лікарем – невропатологом на МРТ, ВЛК на базі КНП «Гребінківська міська лікарня» Гребінківської міської ради.

3. При вибірковій перевірці особових справ військовослужбовців виявлені факти врахування попередніх результатів лабораторно-інструментальних досліджень, без актуальних підтверджень консультацій відповідних спеціалістів та досліджень, ВЛК на базі КНП «Гадяцька міська центральна лікарня» Гадяцької міської ради.

4. В зв'язку з дефіцитом кадрів, має місце одночасної роботи голів ВЛК членами ВЛК, характерно для ВЛК на базі таких закладів:

- КП «Пирятинська міська лікарня Пирятинської міської ради»;
- КНП «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради;
- КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька».

5. В більшості випадків не проводиться оцінка вакцинального статусу військовозобов'язаних, характерно для всіх ВЛК.

6. ВЛК на базі Полтавського та Кременчуцького РТЦК та СП не забезпечені відповідним матеріально-технічним обладнанням, відсутній окремий кабінет для прийому лікаря-психіатра.

6. ВЛК на базі КП «4-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради ім. Л.Куроедова» не укомплектована лікарем – психіатром.

7. Відсутні добровільні згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та добровільні згоди на психіатричний огляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу» в усіх ВЛК;

8. Виявлені факти не обгрунтованих діагнозів на базі ВЛК таких закладів:

- КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»;
- КНП «Новосанжарська центральна районна лікарня» Новосанжарської селищної ради Полтавського району;
- КНП «Гадяцька міська центральна лікарня» Гадяцької міської ради;
- КНП «Чорнухінська лікарня» Чорнухінської селищної ради;
- КП «Семенівська лікарня» Семенівської селищної ради

Рівненська область:

Було проведено перевірки 16 ВЛК на базі закладів охорони здоров'я:

1. Книга протоколів засідань ВЛК продовжує вестись в паперовому варіанті та фактично дублює інформацію, яка вводиться в Е-ВЛК, характерно для ВЛК на базі:
 - КП «Регіональний центр орфанних захворювань, радіаційного захисту спеціалізованої допомоги» Рівненської обласної ради;
 - КНП «Міська лікарня №2» Рівненської міської ради;
2. Клінічний маршрут пацієнтів потребує коректуванню, зокрема відсутні скерування на обстеження МРТ, КТ обстеження, характерно для ВЛК на базі;
 - КНП «Корецька міська лікарня» Корецької міської ради;
3. Карта обстеження та медичного огляду військовослужбовця (додаток 13) видається йому на руки, що унеможлиблює здійснення контролю за дотримання термінів проходження оглядів, характерно для ВЛК на базі таких закладів:
 - КНП «Здолбунівська центральна міська лікарня» Здолбунівської міської ради;
 - КНП «Острозька багатoproфільна лікарня» Острозької міської ради;
 - КНП «Корецька міська лікарня» Корецької міської ради;
4. В пункті 9 додатку 13 в окремих випадках не вказується діагноз, а зазначається лише ступень придатності, характерно для ВЛК на базі закладів:
 - КНП «Гощанська багатoproфільна лікарня» Гощанської селищної ради;
 - КНП «Корецька міська лікарня» Корецької міської ради;
 - КНП Вараської міської ради «Вараська багатoproфільна лікарня»;
 - КНП «Володимирська багатoproфільна лікарня» Володимирської селищної ради;
 - КНП «Рокитнівська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Рокитнівської селищної ради.
5. Не оформляються добровільні згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та добровільні згоди на психіатричний огляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу». Характерно для усіх ВЛК.
6. ВЛК на базі КНП «Демідівська центральна районна лікарня» Демідівської селищної ради виявлені випадки направлення на дообстеження (в журналі ВЛК), але така інформація в ЕСОЗ, МІС.
7. Виявлені порушення в формулюванні діагнозу ВЛК на базі КНП «Костопільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради.
8. Виявлені випадки перевищення термінів проходження медичних оглядів ВЛК на базі КНП «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської міської ради;
9. ВЛК на базі КНП «Рокитнівська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Рокитнівської селищної ради виносять постанови які перебувають у компетенції госпітальної ВЛК, необґрунтовані рішення про непридатність.

Сумська область:

Було проведено перевірку 17 ВЛК на базі закладів охорони здоров'я.

1. Не проводиться інформування громадян, в закладах відсутні інформаційні стенди щодо порядку проходження військово-лікарської експертизи в більшості ВЛК на базі закладів охорони здоров'я.

2. ВЛК не працюють у вихідні дні на базі таких закладів:

- КНП «Буринська лікарня імені професора М.П. Новаченка»;
- КНП «Центральна міська клінічна лікарня»,

3. Зафіксовані порушення в кадровому забезпеченні ВЛК, працює лише одна медична сестра ВЛК на базі:

- КНП Конотопської міської ради «Конотопська центральна районна лікарня імені академіка Михайла Давидова»;
- КНП «Тростянецька міська лікарня» Тростянецької міської ради.

Тернопільська область:

Було проведено перевірок 18 ВЛК на базі закладів охорони здоров'я.

Виявлено наступні порушення:

1. Виявлені випадки не закритих епізодів в ЕСОЗ. Всього по області не завершили медичний огляд взагалі – 248 осіб (1,1%); не завершили медичний огляд понад 14 днів – 5 осіб (0,02%). Маршрути пацієнтів потребують корегування.

Такі порушення більше характерні для ВЛК таких закладів:

- КНП «Бучацька міська лікарня» Бучацької міської ради;
- КНП «Козівська центральна районна лікарня Козівської селищної ради.

Харківська область:

Було проведено перевірку 30 ВЛК на базі закладів охорони здоров'я. Були виявлені наступні порушення:

1. Виявлені факти заниження ступеню придатності до військової служби військовозобов'язаних, які визнані придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ навчальних центрах характерно для ВЛК на базі таких закладів:

- КНП "Міська поліклініка № 25м Харківської міської ради;
- КНП "Люботинська центральна лікарня" Люботинської міської ради

2. Штат ВЛК на базі КНП «Дергачівська центральна лікарня», КНП «Студентська міська лікарня не укомплектований, голова ВЛК виконує функції члена-ВЛК, як лікар-спеціаліст відповідного профілю.

Хмельницька область:

Було проведено перевірки 21 ВЛК на базі закладів охорони здоров'я:

1. Недостатній контроль термінів проведення медичних оглядів. По області не завершили медичний огляд взагалі - 632 (2,8%), не завершили медичний огляд більше 14 днів – 632 (2,8%). Більше характерно для ВЛК таких закладів:

- ВЛК на базі КНП «Вінковоцька багатoproфільна лікарня» Вінковоцької селищної ради;
- ВЛК на базі КНП «Волочиська багатoproфільна лікарня» Волочиської міської ради Хмельницького району;

- ВЛК на базі КНП «Деражнянська міська багатoproфільна лікарня» Деражнянської міської ради;
 - ВЛК на базі КНП «Теофіпольська багатoproфільна лікарня» Теофіпольської селищної ради;
 - ВЛК на базі КНП «Хмельницький МЛДЦ» Хмельницької міської ради;
 - ВЛК на базі КНП «Славутська міська лікарня ім. Ф.М. Михайлова».
2. Не дотримується або відсутній маршрут військовослужбовців, характерно для ВЛК таких закладів:
- ВЛК на базі КНП «Волочиська багатoproфільна лікарня» Волочиської міської ради Хмельницького району;
 - ВЛК на базі КНП «Теофіпольська багатoproфільна лікарня» Теофіпольської селищної ради;
 - ВЛК на базі КНП «Славутська міська лікарня ім. Ф.М. Михайлова»:
4. Не проводиться перевірка вакцинального статусу військовозобов'язаних, характерно ВЛК на базі КНП «Хмельницька центральна районна лікарня» Хмельницького району.

Черкаська область:

Було проведено повторні перевірки 9 з 24 ВЛК на базі закладів охорони здоров'я. Були виявлені наступні порушення:

1. Оформлення документації за підсумками медичних оглядів військовозобов'язаних (далі в/з) проводиться з недотриманням вимог наказу МО України від 14.08.2008 № 402, має місце не відповідність ступеню придатності та діагнозу; порушення характерні для ВЛК на базі таких закладів:
 - КНП «Золотоніська багатoproфільна лікарня» Золотоніської міської ради;
 - КНП «Городищенське медичне об'єднання» Городищенської міської ради;
 - КНП «Корсунь – Шевченківська багатoproфільна лікарня» Корсунь-Шевченківської міської ради;
 - КНП «Смілянська багатoproфільна лікарня» Смілянської міської ради;
 - КНП «Кам'янська багатoproфільна лікарня» Кам'янської міської ради.
2. Не відповідає вимогам набір приміщень окремих ВЛК. Є випадки, що в одному кабінеті здійснюють прийом отоларинголог, офтальмолог, хірург, травматолог, що унеможливорює якісний фізичний огляд. В одному кабінеті оглядає лікар-психіатр і лікар-терапевт, що є порушенням закону України «Про психіатричну допомогу» Характерно для ВЛК на базі:
 - КНП «Смілянська багатoproфільна лікарня» Смілянської міської ради
3. Оцінка вакцинального статусу військовозобов'язаних не проводиться по більшості ВЛК.
4. Не здійснюється контроль направлень на додаткове обстеження ВЛК. Всього по області направлень на додаткові обстеження 2587 (9,8%). Більше характерно для ВЛК на базі таких закладів:
 - КНП «Смілянська багатoproфільна лікарня» Смілянської міської ради;
 - КНП «П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
5. Не відповідає комплектація штату ВЛК на базі закладів:

- КНП «Черкаська обласна лікарня» Черкаської обласної ради, до складу комісії не введені лікар – дерматолог, лікар – стоматолог.

6. Виявлені випадки необґрунтованості діагнозів, у справах в/з відсутні первинна документація, результати додаткових методів обстеження, які необхідні для верифікації діагнозу, характерно для ВЛК на базі КНП «Канівська багато профільна лікарня» Канівської міської ради.

Чернівецька область:

Було проведено перевірки 13 ВЛК на базі закладів охорони здоров'я.

Були виявлені порушення, зокрема, не обґрунтовано направляються військовозобов'язані на додаткові обстеження, маршрути проходження військово-лікарської експертизи потребують корегуванню з врахуванням інклюзивності приміщень, виявлені випадки незакритих епізодів в ЕСОЗ, ВЛК на базі таких закладів:

- КНП «Заставніська багато профільна лікарня» Юрковецької сільської ради;
- КНП «Вижницька міська лікарня» Вижницької міської ради;
- КНП «Путильська багато профільна лікарня» Путильської селищної ради;
- КНП «Міська поліклініка №2» Чернівецької міської ради, 3745 пацієнтів скеровано на «консультацію травматолога» (5% від усіх направлень по країні);

4. Не укомплектований штат ВЛК на базі:

- КНП «Сокирянська лікарня» Сокирянської міської ради.

Чернігівська область:

Було проведено перевірки 27 ВЛК на базі закладів охорони здоров'я. Виявлені наступні порушення:

1. В електронних свідоцтвах про хворобу не завжди зазначається ступінь функціональних порушень в діагнозах пацієнтів, які визнаються не придатними до військової служби.
2. Пацієнтам, які визнаються не придатними до військової служби в основному діагнозі зазначається підтвердження клінічно, в той час коли потрібне інструментальне підтвердження основного діагнозу.
3. Виявлені випадки, коли по окремим діагнозам лікарі не зазначають ступінь функціональних порушень.

Такі порушення характерні для ВЛК на базі таких закладів:

- КНП «Семенівська міська лікарня» Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
- КНП «Сновська центральна районна лікарня» Корюківського району Чернігівської області.
- КНП «Новгород-Сіверська центральна міська лікарня» Чернігівської області.
- КНП «Корюківська центральна міська лікарня» Чернігівської області.

4. Не вводиться інформація в повному обсязі в систему Е-ВЛК ВЛК на базі КНП «Прилуцька центральна районна лікарня» Прилуцької районної ради Чернігівської області.

м. Київ:

Було проведено перевірки 14 ВЛК на базі закладів охорони здоров'я. Виявлені наступні порушення:

1. ВЛК на базі КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва зафіксовані порушення вимог п.п.2.8.1, п. 2.8, розділу 1 наказу Міністерства оборони України від 14.08.2008 № 402 (зі змінами) – лікар-терапевт являється головою ВЛК (має бути окрема особа).
2. ВЛК на базі КНП «Консультативно-діагностичний центр № 1» Дарницького району м. Києва діагноз встановлюються без підтвердження медичної документації; постанови ВЛК приймаються на підставі попередньої довідки, порушення виявлено.
3. КДЦ Солом'янського району Києва – 2585 пацієнтів скеровано на «консультацію інфекціоніста» (11,7% від усіх направлень по країні, при цьому 16,5% не завершили дообстеження), що свідчить про недостатній контроль.

Таким чином, за результатами проведених перевірок можна виділити наступні системні порушення:

1. Не завжди використовується електронний документообіг, Е-направлення не завжди формуються, що унеможливує проведення дообстеження в необхідний термін, більше характерно для ВЛК Миколаївської, Львівської та Чернігівської областей.
2. Не контролюються терміни дообстеження військовозобов'язаних, виявлені випадки безпідставного направлення на дообстеження з окремими діагнозами (при наявності відповідних спеціалістів у складі ВЛК), більше характерно для ВЛК Хмельницької, Тернопільської, Рівненської, Львівської, Житомирської, Запорізької, Закарпатської, Дніпропетровської, Вінницької, Чернівецької, Сумська, Кіровоградської, Полтавської, Київська областей та м. Київ.
3. Штат ВЛК окремих закладів не укомплектований в повному обсязі. У деяких ВЛК вузькі спеціалісти приймають 1-2 рази на тиждень. Окремі ВЛК не укомплектовані лікарями – психіатрами, лікарями – офтальмологами, отоларингологами, більше характерно для ВЛК Черкаської, Харківської, Київської, Дніпропетровської, Житомирської Черкаської, Закарпатської областей.
5. Не всі голови і члени ВЛК пройшли тематичне удосконалення (підготовку) з питань військово-лікарської експертизи для голови та членів ВЛК окремих комісій, більше характерно для ВЛК Київської області.
6. Не забезпечені умови для роботи ВЛК, окремі приміщення не відповідають вимогам, більше характерно для ВЛК Черкаської, Київської, Полтавської, Житомирської областей.
7. Не забезпечений супровід військовозобов'язаних працівниками ТЦК та СП, інформація для організації розшуку не передається до ТЦК, більше характерно для ВЛК Миколаївської, Житомирської, Закарпатської, Вінницької областей.
8. Є випадки не обґрунтованих постанов ВЛК та факти відсутності медичної документації як на базі ВЛК, так і в ТЦК СП, виявлена частина діагнозів, які не підтверджені дослідженнями, виявлені факти заниження ступеню придатності до

військової служби військовозобов'язаних, більше характерно для ВЛК м. Київ, Чернігівської, Чернівецької, Черкаської, Харківської, Рівненської, Полтавської, Миколаївської, Львівської, Київської, Львівської, Закарпатської, Волинської, Вінницької областей.

9. Не дотримуються маршрути проходження військовозобов'язаних при проходженні медичних оглядів, більше характерно для Хмельницької, Рівненської, Львівської, Запорізької, Миколаївської, Кіровоградської, Закарпатської, Дніпропетровської, Сумської, Житомирської областей.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ:

1. Міністерству оборони України спільно з Командуванням медичних сил Збройних Сил України:

1.1. провести повторні додаткові навчання для голів та лікарів військово-лікарських комісій по методиці огляду військовозобов'язаних по встановленню діагнозів відповідно до наказу Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» (зі змінами) Київської, Вінницької, Чернігівської, Черкаської, Рівненської, Полтавської, Миколаївської, Кіровоградської, Житомирської, Закарпатської, Львівської областей та м. Київ;

1.2. надати додаткові роз'яснення для територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та ВЛК щодо норм наказу Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» (зі змінами);

1.3. проаналізувати можливість введення електронного документообігу при проходженні ВЛК в повному обсязі Миколаївської та Львівської областей та пришвидшити внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України».

2. Головам Миколаївської, Житомирської, Закарпатської, Вінницької, Чернівецької, Полтавської обласних державних (військових) адміністрацій:

2.1. взяти на особистий контроль питання взаємодії позаштатних військово-лікарських комісій закладів охорони здоров'я з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки;

2.2. забезпечити спільно з регіональною військово-лікарською комісією здійснення виїзних моніторингових візитів до ВЛК не менше 1 разу на квартал з метою перевірки організації проведення медичних оглядів.

3. Директорам Департаментів охорони здоров'я обласних військових адміністрацій:

3.1. взяти на контроль виконання закладами охорони здоров'я вимог пакету № 60 НСЗУ «Програма медичних гарантій»;

3.2. посилити моніторинг стосовно надання лікарями загальної практики сімейної медицини інформації щодо вакцинального статусу військовозобов'язаних до початку проходження військово-лікарської експертизи;

3.3. проаналізувати оснащення кабінетів спеціалістів позаштатних військово-лікарських комісій закладів охорони здоров'я та зобов'язати керівників цих закладів доукомплектувати кожен кабінет відповідно до табеля оснащення (для структурних підрозділів з охорони здоров'я Черкаської, Київської, Полтавської, Житомирської обласних (військових) адміністрацій);

3.4. забезпечити контроль щодо наявності та дотримання маршруту військовозобов'язаних під час проходження військово-лікарської експертизи (для структурних підрозділів з охорони здоров'я Хмельницької, Рівненської, Львівської, Запорізької, Миколаївської, Кіровоградської, Закарпатської, Дніпропетровської, Сумської, Житомирської обласних (військових) адміністрацій);

3.5. посилити моніторинг за внесенням даних до електронної системи охорони здоров'я (для структурних підрозділів з охорони здоров'я Миколаївської, Львівської та Чернігівської обласних (військових) адміністрацій);

3.6. провести позачергову нараду з керівниками закладів охорони здоров'я та головами ВЛК, на якій проаналізувати роботу кожної ВЛК щодо обґрунтованості встановлення діагнозів та ступенів порушення функції згідно вимог Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» (зі змінами);

3.7. проаналізувати укомплектованість штатами ВЛК, вжити заходів щодо виправлення ситуації (для структурних підрозділів з охорони здоров'я Черкаської, Харківської, Київської, Дніпропетровської, Житомирської Черкаської, Закарпатської обласних (військових) адміністрацій);

3.8. взяти під особистий контроль питання дотримання термінів проходження дообстеження військовозобов'язаних (для структурних підрозділів з охорони здоров'я Хмельницької, Тернопільської, Рівненської, Львівської, Житомирської, Запорізької, Закарпатської, Дніпропетровської, Вінницької, Чернівецької, Сумська, Кіровоградської, Полтавської обласних (військових) адміністрацій);

3.9. проаналізувати випадки необґрунтованих постанов ВЛК, випадки необґрунтованих діагнозів та факти відсутності медичної документації як на базі ВЛК, так і в ТЦК СП, факти заниження ступеню придатності до військової служби військовозобов'язаних (для структурних підрозділів з охорони здоров'я Київської міської, Чернігівської, Чернівецької, Черкаської, Харківської, Рівненської, Полтавської, Миколаївської, Львівської, Київської, Львівської, Закарпатської, Волинської, Вінницької обласних (військових) адміністрацій).

4. Керівникам закладів охорони здоров'я, на базі яких працюють позаштатні ВЛК:

4.1. розробити, або скоректувати наявні та затвердити маршрути проходження військово-лікарської експертизи військовозобов'язаними; , забезпечивши візуалізацію в доступному для громадян місці інформаційних матеріалів щодо наявності та роботи ВЛК, вказівники руху/маршруту для ВЗ

громадян, які проходять обстеження на ВЛК;

4.2. привести у відповідність до вимог нормативно-правової бази щодо часу та днів роботи комісій, у тому числі у вихідні, святкові дні, тощо;

4.4 забезпечити окремим приміщенням ВЛК та окремими кабінетами членів ВЛК для огляду військовозобов'язаних;

4.5 привести у відповідність кабінети членів ВЛК та їх матеріально-технічне забезпечення до вимог чинного законодавства;

4.6. забезпечити проходження головою та членами ВЛК додаткових навчань щодо питань військово-лікарської експертизи та дотримання чинного законодавства в питаннях направлення на психіатричну експертизу;

4.7. забезпечити електронний документообіг;

4.8. забезпечити контроль за дотриманням наказу Міноборони від 14.08.2008 № 402 (зі змінами) «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», проведенням медичного огляду військовозобов'язаних у повному обсязі, забезпеченням обґрунтованості діагнозів.

5. Головам позаштатних ВЛК при ТЦК та СП:

5.1. посилити контроль за веденням документації та дотриманням вимог наказу Міноборони від 14.08.2008 № 402 (зі змінами) «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», зокрема щодо винесення експертних рішень та постанов;

5.2. проводити чіткий контроль за веденням медичної документації та прийняттям постанов;

5.3. вживати заходи щодо недопущення необґрунтованої гіпердіагностики захворювань, що впливає на винесення рішень ВЛК;

5.4. контролювати питання обґрунтованості скерувань військовозобов'язаних на дообстеження, зокрема МРТ, консультації до інших закладів охорони здоров'я (особливо до закладів психіатричної допомоги), а також визначення маршрутизації військовозобов'язаних на дообстеження;

5.5. проводити оцінку вакцинального статусу військовозобов'язаних та в разі потреби направляти їх на проведення вакцинації відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень в Україні

5.6. у випадках винесення рішення ВЛК «виключення з військового обліку», «придатний для служби у військових частинах забезпечення...», забезпечити наявність у картці обстеження та медичного огляду військово-лікарською комісією (додаток 13 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України) оригіналів первинної медичної документації;

5.7. повідомляти територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про випадки затягування проходження ВЛК шляхом вручення офіційного листа або направлення рекомендованого листа;

5.8. запровадити контроль за введенням епізодів в електронну систему охорони здоров'я.

6. Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки:

6.1. посилити супровід та взаємодію з ВЛК працівниками ТЦК та СП щодо забезпечення контролю за термінами проходження дообстеження;

6.2. забезпечити супровід військовозобов'язаних під час проходження військово-лікарської експертизи.

**Заступник директора Департаменту
медичних послуг МОЗ України**



Андрій Нечипорук